

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Test de Fagerström de Dependencia de la Nicotina (FTND)

Eje VI • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1. Identificación

Familia / sigla	FTND
Nombre completo	Fagerström Test for Nicotine Dependence — Test de Fagerström de Dependencia de la Nicotina
Versión / edición	Versión revisada de 6 ítems (Heatherton et al., 1991), reproducida en hoja clínica española.
Idioma	Español.
Autores	Fagerström KO (original 1978); revisión Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO (1991). Uso/validación en español: Carrasco, Luna, Vila (1994); Córdoba et al. (2000).
Año	1978 (original); 1991 (revisión de 6 ítems aquí reproducida).
Tiempo estimado	2 a 3 minutos

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Etiquetas	Tabaco; dependencia a la nicotina; conducta adictiva; medicina conductual.
Pregunta clínica que responde	¿Qué factores corporales/médicos/conductuales inciden?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: grado de dependencia física a la nicotina en fumadores, a partir de indicadores conductuales (tiempo hasta el primer cigarrillo, dificultad para abstenerse en lugares prohibidos, cigarrillo más difícil de abandonar, número de cigarrillos/día, patrón de consumo matutino, consumo pese a enfermedad).

Finalidad: cribado breve y heteroadministrado de la intensidad de la dependencia a la nicotina, para orientar decisiones de tratamiento de deshabituación tabáquica (p. ej. necesidad de terapia sustitutiva de nicotina u otro apoyo farmacológico).

Usos apropiados:

- Cribado de intensidad de dependencia a la nicotina en fumadores, en consulta de atención primaria o programas de deshabituación tabáquica.
- Orientación sobre la necesidad e intensidad de apoyo farmacológico (p. ej. terapia sustitutiva de nicotina) en el tratamiento del tabaquismo.
- Seguimiento de la evolución de la dependencia a lo largo de un proceso de cesación tabáquica.

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico formal de trastorno por consumo de tabaco según criterios CIE-11 o DSM-5-TR (requiere entrevista clínica estructurada adicional).
- Evaluación de otros tipos de consumo de nicotina no combustible (vapeo, tabaco sin humo) sin adaptación específica del instrumento.
- Sustituto de evaluación médica integral en pacientes con comorbilidad respiratoria o cardiovascular relevante.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Población general fumadora, adultos.
Contexto de aplicación	Atención primaria, consultas de deshabituación tabáquica, neumología, medicina conductual.
Informante	Heteroadministrado (aplicado por un profesional; la hoja fuente lo describe explícitamente como 'escala heteroadministrada').
Modalidad de administración	Papel y lápiz, en consulta clínica.

5. Estructura y administración

Número de ítems	6
Periodo temporal de referencia	no verificado
Formato de respuesta	4 ítems dicotómicos y 2 de opción múltiple
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 2-3 minutos, dada su brevedad).

6. Dimensiones y puntuaciones

Instrumento unidimensional: no tiene subescalas; los 6 ítems se suman en una puntuación total única de dependencia a la nicotina.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma de los 6 ítems: tiempo hasta el primer cigarrillo (hasta 5 min=3, 6-30 min=2, 31-60 min=1, >60 min=0); dificultad para no fumar en lugares prohibidos (Sí=1, No=0); cigarrillo que más molesta dejar (el primero de la mañana=1, cualquier otro=0); cigarrillos/día ($\leq 10=0$, 11-20=1, 21-30=2, $\geq 31=3$); fuma más en las primeras horas (Sí=1, No=0); fuma estando enfermo en cama (Sí=1, No=0).
Ítems invertidos	No aplica; todos los ítems puntúan en el mismo sentido (mayor puntaje = mayor dependencia).
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible / puntos de corte	0-10. Dependencia baja: <4. Dependencia moderada: 4-7. Dependencia alta: >7. Fuente: hoja clínica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN), que cita a Fagerström (1978), Carrasco et al. (1994), Lee & D'Alonzo (1993) y Córdoba et al. (2000).

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Carrasco TJ, Luna M, Vila J (1994). Validez del Fagerström Tolerance Questionnaire como medida de dependencia física de la nicotina: una revisión. *Rev Esp Drogodependencias*, 19(1), 3-14. Córdoba R, Martín C, Casas R, Barbera C, Botaya M, Hernández A, Jané C (2000). Valor de los cuestionarios breves en la predicción del abandono del tabaco en atención primaria. *Aten Primaria*, 25(1), 32-36. No se verificaron en esta sesión coeficientes de fiabilidad/validez cuantitativos específicos de estas referencias (solo se accedió a la cita en la hoja clínica fuente, no al texto completo de los artículos) — no verificado, consultar las fuentes primarias antes de citar cifras exactas.

9. Adaptación cultural y norma local

Ampliamente utilizado en la práctica clínica española de deshabituación tabáquica (recursos hospitalarios como el HUVN de Granada lo reproducen como hoja clínica estándar); no se verificó en esta sesión una adaptación normativa formal y diferenciada para países de Latinoamérica.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- Es la versión revisada de 6 ítems (Heatherton et al., 1991); no confundir con el Fagerström Tolerance Questionnaire original de 8 ítems (1978) al comparar con estudios que usan la forma larga.
- Instrumento de cribado de dependencia física, no diagnóstico formal de trastorno por consumo de tabaco (CIE-11/DSM-5-TR).
- Descrito como heteroadministrado en la fuente clínica utilizada; su uso como autoinforme puro no fue verificado específicamente.
- No sustituye evaluación médica integral, especialmente en pacientes con comorbilidad respiratoria o cardiovascular.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El FTND es un instrumento clínico de dominio consuetudinario en la práctica de deshabituación tabáquica, ampliamente reproducido en hojas clínicas y guías de práctica sin restricción editorial identificada para uso académico/asistencial no comercial. Se accedió a través de una hoja clínica pública del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN, Granada). El Protocolo.pdf de este acervo es una reconstrucción textual verificada (no el binario original, que el entorno de red de este proceso no pudo descargar).

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Fagerström KO (1978). Measuring degree of physical dependence to tobacco smoking with reference to individualization of treatment. *Addictive Behaviors*, 3(3-4), 235-241.

Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO (1991). The Fagerström Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. *British Journal of Addiction*, 86(9), 1119-1127.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves (HUVN). Dependencia de la Nicotina - Test de Fagerström.

https://www.huvn.es/archivos/cms/enfermeria-en-huvn/archivos/publico/cuestionarios/Cuestionarios-3/dependencia_a_la_nicotina.pdf

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (reconstrucción textual verificada con reportlab, 6 ítems completos + escala de puntuación + bibliografía citada). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Protocolo reconstruido abre correctamente y contiene el texto íntegro verificado (comprobado con pypdf). Requiere revisión humana antes de uso clínico formal.

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0